複雑性PTSD（C-PTSD）治療法エビデンスサマリー

検索日: 2026-03-20

C-PTSDとは（3行以内）

複雑性PTSD（ICD-11収載）は、反復・持続的なトラウマ（小児期虐待・DV・人身売買など）に曝露された後に生じる疾患単位であり、通常PTSDの3症状群（再体験・回避・過覚醒）に加え、「自己組織化の障害（DSO）」として情動調節困難・否定的自己概念・対人関係障害の3症状群が加わる点が特徴的である。ISTSSは2018年に成人および小児向けのポジションペーパーを発表し、PTSDとは独立した治療戦略の開発の必要性を強調している。

治療アプローチ別エビデンス

---

1. EMDR（眼球運動による脱感作と再処理）

エビデンスレベル: システマティックレビュー（RCT含む） **推奨度:** 弱い推奨（C-PTSD特異的エビデンスは限定的） **主な知見:** Karatzias et al.（2019）のメタ解析（RCT 51件）では、EMDRはPTSD症状に対して通常ケアより有意に優れており（g = −1.26、95%CI −2.01〜−0.51）、否定的自己概念・対人関係にも中等度〜大の効果量を示した。ただし、データ件数は少ない（k=4）。複雑性幼少期トラウマを対象とした別のSR（Chen et al., 2018、RCT 6件）でも、EMDR後にPTSD症状・うつ・不安の有意な改善を認め、CBTや薬物療法との比較でも良好な結果が示された。青年C-PTSDへのケースシリーズ（Rolling et al., 2024）では、3ヶ月のEMDRでPTSD症状・抑うつ・睡眠・QOLが全て有意改善した。 **限界・注意点:** 乖離（解離）症状が強い症例では反応が乏しく、幼少期発症トラウマほど効果が低下する傾向があり（Karatzias 2019）、解離症状への事前介入が推奨される。 **主要文献:** - PMID: 30857567（Karatzias T et al., Psychological Medicine, 2019） - PMID: 29695993（Chen R et al., Frontiers in Psychology, 2018）- DOI: 10.3389/fpsyg.2018.00533 - PMID: 39408173（Rolling J et al., Healthcare, 2024）- DOI: 10.3390/healthcare12192009

---

2. トラウマフォーカスト認知行動療法（TF-CBT / PE / CPT）

エビデンスレベル: メタ解析・複数RCT **推奨度:** 弱い推奨（C-PTSDへの特化データは限定的、PTSD全般では強い推奨） **主な知見:** Korovynskyi et al.（2025）のメタ解析（RCT 45件、n=4,267）では、持続エクスポージャー（PE: d=1.24）、認知処理療法（CPT: d=1.16）、TF-CBT（d=1.08）いずれも大きな効果量を示した。治療反応率はPE 68%、CPT 64%、標準CBT 61%。Ahn et al.（2025）のSRでは、STAIR（スキルトレーニング+語りセラピー）を含むフェーズ基盤型アプローチがC-PTSDのDSO症状にも有効と示唆。成人C-PTSDには長期・段階的介入が望ましい。 **限界・注意点:** 感情調節不全・BPD併存例ではドロップアウト率が高く（DBT-PTSDとの比較RCTでCPT群39%脱落）、重症情動障害例への単独適用には慎重を要する。 **主要文献:** - PMID: 40737648（Korovynskyi I et al., Georgian Medical News, 2025） - PMID: 41218591（Ahn H et al., J Korean Med Sci, 2025）- DOI: 10.3346/jkms.2025.40.e335 - PMID: 36070830（Grau PP et al., J Affect Disord, 2022）

---

3. 弁証法的行動療法（DBT-PTSD）

エビデンスレベル: RCT（2件）・長期フォローアップ研究 **推奨度:** 強い推奨（幼少期虐待関連C-PTSD＋感情調節障害・BPD併存例） **主な知見:** Bohus et al.（2020、JAMA Psychiatry）のRCT（n=193）では、DBT-PTSDがCPTと比較してCAPS-5スコアで有意に優れ（d=1.35 vs 0.98、群間差d=0.33）、寛解率（58.4% vs 40.7%）・脱落率低下（25.5% vs 39.0%）でも有意に優れた。治療効果は9ヶ月フォローアップでも維持され（Vonderlin et al., 2024）、BSL-23・GAFでも中等度の群間効果量（d=0.57）を示した。2025年のSchaug et al.のガイドライン（BMJ Mental Health）でも、BPD併存C-PTSDにはDBT-PTSDを弱く推奨。 **限界・注意点:** 外来45週・入院12週という長期・集中的プログラムであり、実施可能な施設が限られる。現状では女性・幼少期性的/身体的虐待例に特化したエビデンスが主体である。 **主要文献:** - PMID: 32697288（Bohus M et al., JAMA Psychiatry, 2020）- DOI: 10.1001/jamapsychiatry.2020.2148 - PMID: 39221987（Vonderlin R et al., Eur J Psychotraumatol, 2024）- DOI: 10.1080/20008066.2024.2390012 - PMID: 38874612（Bohus M, Vonderlin R. Der Nervenarzt, 2024） - PMID: 40234083（Schaug JP et al., BMJ Mental Health, 2025）- DOI: 10.1136/bmjment-2024-301367

---

4. スキーマ療法（Schema Therapy: ST）

エビデンスレベル: 症例報告・症例シリーズ・パイロット研究 **推奨度:** 研究段階（推奨なし） **主な知見:** van Hemert et al.（2025）のレビュー＋ケーススタディでは、ST・イメージリスクリプティング（ImRs）・EMDRの段階的統合アプローチがC-PTSDに有効である可能性を示した（CAPS-5が重篤から臨床閾値未満へ改善）。難民の治療抵抗性PTSD＋パーソナリティ病理に対するグループスキーマ療法（Verhaak et al., 2024）では、治療順守の改善とその後のトラウマフォーカス療法への橋渡しとして有望とされた。 **限界・注意点:** RCTがほぼ存在せず、C-PTSD特異的なエビデンスは症例レベルに留まり、単独での有効性確立には更なる研究が必要である。 **主要文献:** - PMID:

41160015（van Hemert MTC et al., Eur J Psychotraumatol, 2025）- DOI: 10.1080/20008066.2025.2502139 - PMID: 38434423（Verhaak L et al., Case Rep Psychiatry, 2024）- DOI: 10.1155/2024/5591095

---

5. IFS（内的家族システム療法）

エビデンスレベル: フィージビリティ研究（パイロット） **推奨度:** 研究段階（推奨なし） **主な知見:** Comeau et al.（2024）のパイロット研究（n=15）では、オンライングループベースのIFSプログラム（PARTS: 週1回90分×16週＋個別8回）の忍容性は良好で（12回以上参加73%）、PTSD重症度（CAPS-5）が有意に低下し（16週p=.005）、24週時点で53%が臨床的有意な反応（10点以上改善）を示した。自己慈悲・感情調節・脱中心化も改善した。 **限界・注意点:** 対照群なし・少数例のパイロット研究であり、C-PTSDへの特異的効果を主張するには対照化されたRCTが不可欠である。 **主要文献:** - PMID: 38934934（Comeau A et al., Psychol Trauma, 2024）- DOI: 10.1037/tra0001745

---

6. 薬物療法（SSRI・プラゾシン・ケタミン等）

エビデンスレベル: レビュー・アルゴリズム論文（C-PTSD特化RCTなし） **推奨度:** 弱い推奨（補助療法として） **主な知見:** Bajor et al.（2022、Psychiatry Research）のエビデンスベースアルゴリズムでは、PTSD薬物療法の第一選択は睡眠障害の治療であり、悪夢にはプラゾシン（α1遮断薬）、入眠障害にはヒドロキシジン・トラゾドンを推奨。非睡眠症状が残存すればSSRI（セルトラリン・パロキセチン）を試みる。Burback et al.（2024）の最新レビューでは、SSRIはPTSD全般に中等度の効果を持つが、C-PTSDや複雑性トラウマに特化したRCTはほぼ存在しないことを指摘。ケタミン・向精神薬・TMS・サイケデリクスは現状では確立したエビデンスなく実験段階と位置付けられる。 **限界・注意点:** C-PTSD単独を対象とした薬物療法RCTは実質的に存在せず、薬物療法は心理療法との併用補助として位置付けるべきである。 **主要文献:** - PMID: 36162349（Bajor LA et al., Psychiatry Res, 2022）- DOI: 10.1016/j.psychres.2022.114845 - PMID: 37132142（Burback L et al., Curr Neuropharmacol, 2024）- DOI: 10.2174/1570159X21666230724172309

---

7. ISTSSガイドライン（2018年版・最新推奨）

エビデンスレベル: 臨床ガイドライン（メタ解析208件、RCT 361件に基づく） **推奨度:** 強い推奨8件・標準推奨8件（C-PTSD個別推奨はポジションペーパーに記載） **主な知見:** Bisson et al.（2019）によるISTSSガイドライン開発論文では、2018年ガイドラインは361件のRCTを包括し125の推奨を産出した。C-PTSD（複雑性PTSD）については専用スコーピング疑問設定が見送られた（定義上の問題・専用RCTの欠如）が、ポジションペーパーで「フェーズ基盤型アプローチ」を推奨し、安全確立→トラウマ処理→社会統合という段階的治療の必要性を強調している。TF-CBTおよびEMDRが全般的PTSDに対し強い推奨を受けている（Billings et al., 2025 review）。 **限界・注意点:** 2018年版は一般PTSD中心であり、C-PTSD特化推奨は現状エビデンス不足のため弱い推奨または研究推奨レベルに留まる（Schaug et al., 2025）。 **主要文献:** - PMID: 31283056（Bisson JI et al., J Trauma Stress,

2019）- DOI: 10.1002/jts.22421 - PMID: 41004137（Billings J & Nicholls H, Br Med Bull, 2025）- DOI: 10.1093/bmb/ldaf011 - PMID: 40234083（Schaug JP et al., BMJ Mental Health, 2025）- DOI: 10.1136/bmjment-2024-301367

治療法比較表

治療法	エビデンスレベル	推奨度	特に有効な症状・対象	限界
EMDR	SR・RCT（C-PTSD特化は限定）	弱い推奨	PTSD症状・否定的自己概念・対人関係	解離症状強例・幼少期発症例で効果減弱
TF-CBT/PE/CPT	複数RCT・メタ解析（大規模）	弱い推奨（C-PTSD特化）/強い推奨（PTSD全般）	PTSD核心症状・抑うつ共存例	感情調節不全・BPD共存例の脱落率が高い
DBT-PTSD	RCT 2件・長期フォロー	強い推奨（BPD/感情調節障害共存C-PTSD）	感情調節障害・自傷・慢性希死念慮・対人問題	長期集中プログラム・実施施設限定
スキーマ療法	症例・パイロット	研究段階	早期不適応スキーマ・治療抵抗例の準備段階	RCTなし
IFS	パイロット（小規模）	研究段階	自己慈悲・感情調節・脱中心化	対照試験なし
薬物療法（SSRI等）	レビュー・アルゴリズム	弱い推奨（補助療法）	睡眠障害・悪夢・過覚醒・抑うつ共存	C-PTSD特化RCTほぼ皆無

治療法	エビデンスレベル	推奨度	特に有効な症状・対象	限界
フェーズ基盤型（ISTSS推奨）	ガイドライン	専門家合意	全般（特に重症・複雑例）	最適なフェーズ数・期間は未確立

臨床的示唆（5点以内）

- **段階的（フェーズ基盤型）アプローチが原則：** ISTSSを含む主要ガイドラインは、C-PTSDでは「安全確立 → 安定化 → トラウマ処理 → 社会統合」という段階的治療を推奨しており、トラウマ処理技法を性急に導入することは禁忌に近い。

- **BPD/感情調節障害併存例にはDBT-PTSDが最も強いエビデンス：** 幼少期虐待後C-PTSD＋3つ以上のBPD基準を満たす症例では、CPTより有意に優れた寛解率（58%）・長期維持効果が示されており、第一選択として検討すべきである（PMID: 32697288）。

- **EMDRとTF-CBTは一般PTSDと同等の証拠水準でC-PTSDにも使用可能だが限界あり：** 解離症状が顕著な場合や幼少期発症トラウマでは、まず解離安定化介入を先行させ、EMDRの直接適用には準備フェーズが不可欠である。

- **薬物療法は補助的位置づけ：** SSRIはPTSD全般に中等度の効果を持つが、C-PTSD特化RCTは存在しない。悪夢・睡眠障害にはプラゾシン、過覚醒に対するSSRIは心理療法との併用で検討する。ケタミン・サイケデリクスは現段階では研究段階に過ぎない。

- **スキーマ療法・IFSは有望だがエビデンスは初期段階：** 治療抵抗例や他の療法の準備段階として統合的に用いる可能性はあるが、C-PTSD単独での推奨を支持するRCTはまだ存在せず、標準治療として提供する前にRCTが求められる。

本サマリーは*PubMed MCP*を用いて*2026-03-20*に検索・作成。引用文献は*PMID*・*DOI*を記載。